

神経・筋疾患理学療法学 講義の方針

2027 年度前期 神経理学療法学 II 章担当

学問で終わらせない、臨床につながる理解を

- ・ 授業内容が学生の中で持続する知識として定着すること
- ・ 臨床場面で「何を評価し、どうリハビリすべきか」が実際に分かる状態を目指す
- ・ 講義で扱った疾患について、実習で担当した場合に評価・介入の方向性を組み立てられるようにする

動画を活用した症状イメージの獲得

- ・ 実際の動画などを積極的に活用し、疾患特有の動きや症状の具体的なイメージを持てるようにする
- ・ 疾患概要の理解のために生成 AI で作成した漫画形式の資料なども使用を検討する
患者様の症状(疾患の特徴)→日常生活等で困っている場面→理学療法士の役割

学ぶ意義の実感

- ・ 疾患を学ぶ前に「なぜこれを学ぶ必要があるのか」を実感を持って伝える
- ・ 例:有病率が高い疾患は、直接の入院原因でなくても併存疾患として遭遇する頻度が高い
著名人で同様の疾患を患った方の紹介
- ・ もし自身、家族がこの疾患になったらどうする？などを具体的にイメージする
- ・ 「試験に出るから」ではなく「臨床上なぜ必要か」を先に理解してもらう

国家試験対策にもつながる内容

- ・ 国家試験の過去問を授業内で活用する
- ・ 「講義内容を理解していれば解ける」という達成感を通じて、自分の理解度・到達度を実感してもらう

授業内での理解度確認

- ・ 各回の途中でセクションごとのまとめ・確認テストを実施し、気軽に理解度をチェックできるようにする
- ・ この理解度チェックは上述した国家試験の過去問を活用する

振り返り用資料の整備

- ・ 授業スライドとは別に、A4 縦 1 枚(疾患により両面・複数枚の場合あり)の振り返り資料を用意する
(できれば教科書がその役割を担ってくれると良いが・・・)
- ・ 実習や国試対策で困ったときに、重要ポイントをすぐ思い出せるようにする
- ・ ネット上で確認・共有できるようにする(患者の個人情報を含まない、公開可能な内容のみ)

口頭での説明力の育成(検討中)

- ・ 頭で理解するだけでなく、学生自身が口頭で説明できるようになる工夫を取り入れたい
- ・ 具体的な方法は今後検討

90 分授業内での集中力・コミュニケーションへの配慮

- ・ 45 分を目安に必ず 5 分間の休憩を挟む
- ・ 集中力の維持に加え、学生からの質問・疑問点に答える時間を意図的に確保する

疾患ごとの丸暗記ではなく、疾患間のつながりを重視

- ・ 各疾患を個別に覚えるのではなく、疾患同士のつながりを意識した構成にする
- ・ 共通する病態のメカニズム、共通して用いる評価項目などを横断的に扱う
- ・ 例:脊髄小脳変性症の後に多系統萎縮症を続けて扱い、類似点と相違点を対比的に理解できるようにする

鑑別のための検査を通じた再学習

- ・ 鑑別診断に必要な検査(特に脳画像などの読影の視点)を扱う中で、関連する解剖学的知識を学び直す機会とする
- ・ 暗記ではなく、「なぜその検査が必要で、何を見ているのか」という基礎に立ち返る

臨床経験に基づいた、実感の伴う内容

- ・ これまでの臨床経験を活かし、患者が実際に困っていたこと、関わりの中でうまくいったこと・いかなかったことなどの具体的な経験を盛り込む
- ・ 教科書的な知識に臨床の実感を伴わせることで、記憶に残りやすい講義にする